HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL II

DRA. DEBBIE WONG

HERNIA INCARCERADA

- Contenido herniario irreductible, viable, sin sufrimiento; generalmente crónica.

HERNIA ESTRANGULADA

- Contenido herniario irreductible con compromiso vascular; generalmente aguda.
- Fisiopatología: cuello reducido, protrusión importante, irreductibilidad, isquemia del contenido, necrosis y sepsis por translocación bacteriana.



HISTORIA CLÍNICA DE LA ESTRANGULACIÓN

- Inicio agudo de dolor severo en el sitio herniario, vómito y ausencia de evacuaciones y gases.
- Antecedentes: estreñimiento, tos, pujo rectal o miccional, flatulencias, cirugías, actividad física, cambios del hábito intestinal.

EXPLORACIÓN FÍSICA DE LA ESTRANGULACIÓN

- Inquietud; saco herniario aumentado, eritematoso o violáceo, frío, a tensión e irreductible; hipersensibilidad; silencio abdominal o ruidos metálicos; desorientación, fiebre y taquicardia.

COMPLICACIONES DE LA ESTRANGULACIÓN

- Deshidratación, insuficiencia renal aguda, isquemia intestinal, resección intestinal, sepsis y fascitis; se evitan con diagnóstico certero y referencia oportuna.

LABORATORIOS

- Leucocitosis o leucopenia, neutrofilia, bandemia, trombocitopenia, descontrol glucémico, lactato elevado y HCO3 bajo (acidosis láctica).

DIAGNÓSTICO

- Siempre clínico; gabinete solo en casos dudosos, sin retrasar el tratamiento; estándar de oro: TAC.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Inicial: reanimación con cristaloides y/o analgesia.
- Definitivo: liberar el contenido, verificar su viabilidad, valorar resección intestinal u omentectomía y reparar la hernia.

REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA

- Indicada en prácticamente cualquier hernia de pared: incisionales extensas, incarceradas con o sin oclusión y estranguladas en fase temprana.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

- Eventraciones supergigantes con obesidad y sin elementos musculoaponeuróticos; fístulas enterocutáneas o foco séptico intraabdominal; cirrosis con ascitis libre.

MALLAS

- PTFE dual mesh plus, fibrina en la malla, barreras bioabsorbibles (hialuronato sódico) y polipropileno con poliglactina 910.